

<抗凝固剤>

みたきで使用している抗凝固剤

ヘパリン 低分子ヘパリン（ダルテパリン） ナファモスタット

ヘパリン



基本はヘパリンを使用する。

半減期：30分～1時間

作用機序（※参考）

トロンビン（II a）と Xa 因子を阻害

II a 因子を阻害→生体内における凝固時間の延長

Xa 因子を阻害→体外循環（回路）における凝固時間の延長

低分子ヘパリン（ダルテパリン）



半減期： 2 ～ 3 時間

作用機序（※参考）

Xa 因子のみを阻害

Xa 因子を阻害→体外循環（回路）における凝固時間の延長

ヘパリンは抗凝固阻害作用が二つあるのに対して、低分子ヘパリンは一つ。

→そのためヘパリンより抗凝固作用が弱い。

- ・ 比較的軽症の出血性病変がある場合
- ・ 止血不良が続く場合
- ・ 内視鏡生検のあとや抜歯後のあと などに使用

ヘパリンより半減期が長く、体内で抗凝固作用が長持ちするためワンショット（初回投与）のみを行い、持続

注入なしでも透析ができる。

ナファモスタット



出血性病変や HIT（ヘパリン起因性血小板減少症）の患者に用いる。

半減期：5～8分

注意点

- ・粉末状のため、5 %ブドウ糖 20 ml で溶解
 - 生理食塩液で溶解すると結晶析出や白濁するため禁忌。
- ・積層型ダイアライザー（H12-4000）の患者では併用禁忌
 - 積層膜は陰性（-）荷電、ナファモスタットは陽性（+）荷電なので膜に吸着される。
- ・アレルギー反応を起こす場合がある
 - 投与量に関わらずアレルギーを起こす場合があるので使用患者に対しては要観察。
 - ワンショットを行うとリスクが上昇するため、みたきではワンショットは行わない。

半減期が5～8分と短いため、みたきではカット無し（透析最後まで投与）で行う。

内容に関する質問や意見等は ME 伊藤までお願いします。